

CARE4DIABETES : UNE INITIATIVE EUROPÉENNE INNOVANTE POUR LA GESTION DU DIABÈTE

La nouvelle initiative de lutte contre le diabète de type 2, Care4Diabetes, a été lancée en janvier dans la région wallonne. Care4Diabetes s'appuie sur une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle, s'inspirant du programme néerlandais Keer Diabetes2 Om. Pendant le déroulement du programme, les participants explorent l'impact de la nutrition, de l'activité physique, du sommeil et de la relaxation sur le diabète de type 2 et expérimentent les bienfaits des changements au travers d'activités de groupe. À long terme, l'ambition de Care4Diabetes est de compléter le travail des diabétologues et médecins généralistes en encourageant les patients à adopter des habitudes bénéfiques pour leur santé en parallèle au traitement.

Depuis 2007, la prévalence du diabète ne cesse d'augmenter en Belgique. Selon les données de l'Agence InterMutualiste (Atlas IMAAIM), 7,1 % de la population a reçu un diagnostic confirmé. En Wallonie, le diabète touche 8,6 % de la population, tandis qu'à Bruxelles et en Flandre, les taux sont respectivement de 6,3 % et 6,4 %. De plus, environ 4 % de la population pourrait être atteinte de diabète sans le savoir, portant la prévalence totale estimée à environ 11 %. Par conséquent, l'amplification des conditions d'accès au trajet de démarrage (anciennement pré-traitement) représente une étape importante pour atteindre les personnes qui ne sont pas conscientes de leur diabète ; le trajet de démarrage inclut entre autres une prise en charge éducative et diététique de tous les nouveaux patients.

À la suite d'échanges avec une représentante des services de santé de l'INAMI, il semble que la prise en charge individuelle dans les trajets de soins fonctionne bien car ils comptabilisent déjà un certain nombre d'usagers. En revanche, les prestations de groupe demeurent largement sous-exploitées. Le programme Care4Diabetes pourrait apporter une réponse à ces opportunités de développement.

PHILOSOPHIE DU PROJET

L'initiative Care4Diabetes s'inspire du programme néerlandais "Keer Diabetes2 Om" de l'organisation néerlandaise Voeding Leefstijl, qui a été lancé il y a 10 ans. Selon les récents résultats publiés dans le British Medical Journal, "Keer Diabetes2 Om" a démontré une diminution moyenne du tour de taille de 8 cm et une perte de

poids de 7 kg, accompagnées d'une réduction de l'utilisation de médicaments chez 67 % des participants. En outre, une amélioration de la fatigue, de l'état de santé global et de la qualité de vie persistait jusqu'à deux ans après l'intervention.

L'initiative européenne Care4Diabetes vise à mettre en œuvre le programme "Keer Diabetes2 Om" approuvé par la Commission européenne en l'adaptant au contexte local. Son caractère innovant repose sur deux piliers essentiels : une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle de la prise en charge d'une part, et d'autre part, sur le soutien mutuel et l'échange d'expérience entre pairs. C'est là que le terme "Care" prend tout son sens en mettant en avant à la fois l'aspect médical et humain du programme.

Care4Diabetes aborde quatre aspects fondamentaux : la nutrition, l'activité physique, le sommeil et la relaxation. Le programme est dispensé de manière collaborative par une équipe comprenant une infirmière, une diététicienne, une coach et un coordinateur. Durant une année, les participants ont l'opportunité de comprendre l'impact de ces facteurs sur le diabète de type 2 et d'expérimenter les bienfaits des changements grâce à des activités de groupe sur les différentes thématiques (entre autres atelier de cuisine, lecture d'étiquettes, élaboration de recettes, coaching, physiologie du diabète de type 2, automesure de la glycémie, partage entre pairs, pratique d'une activité physique en groupe, exercices de relaxation).

Le programme se divise en deux phases distinctes : une première phase intensive de 6 mois, étalée sur 5 jours (initialement 2 jours consécutifs, puis 3 jours répartis au fil des autres mois). La seconde phase comprend une période de suivi, au cours de laquelle une session finale est prévue pour revisiter les points qui pourraient ne pas avoir été suffisamment clairs et aborder l'avenir de manière sereine. L'objectif final est de fournir aux participants des outils nécessaires pour reprendre le contrôle sur leur maladie et améliorer leur bien-être.

AMBITIONS

L'introduction de nouveaux médicaments pour traiter le diabète représente une avancée majeure dans la gestion de la glycémie et la prévention des complications cardio-rénales. Certains de ces médicaments ont également montré la capacité d'induire une perte de poids significative, bien que cette diminution soit nettement plus marquée chez les individus

en surpoids que chez ceux atteints de diabète de type 2. Jusqu'à présent, aucune étude n'a examiné les conséquences de l'arrêt de ces médicaments sur la reprise de poids chez les individus atteints de diabète. Cependant, des recherches récentes portant sur les personnes en surpoids indiquent que, suite à l'arrêt de ces médicaments, les patients ont tendance à regagner du poids et à perdre les bénéfices cardio-métaboliques acquis. Étant donné que le surpoids est l'un des principaux facteurs du diabète de type 2, il est fort probable que cette tendance se vérifie également dans le cas du traitement des patients avec un diabète de type 2. Ainsi, même si ces traitements représentent une découverte clé, ils ne peuvent se substituer à une approche de fond essentielle pour assurer un soutien durable aux patients. Outre les considérations médicales, le maintien d'un traitement médicamenteux à vie pour tous les individus souffrant de diabète de type 2 pourrait entraîner des coûts considérables pour le système de santé.

Dans cette perspective, le programme Care4Diabetes aspire, à long terme, à apporter un soutien aux diabétologues et médecins en encourageant les patients à adopter des habitudes bénéfiques pour leur santé en parallèle au traitement. Sur le plan médical, cela permet de réduire le risque de complications et d'optimiser l'apport médicamenteux. D'un point de vue économique, un tel programme représente un investissement nécessaire et ponctuel susceptible de générer des bénéfices à long terme, comprenant non seulement l'optimisation des médicaments, mais également une amélioration de la santé globale, une réduction de l'absentéisme au travail et une meilleure productivité.

La mise en place d'une collaboration synergique entre les professionnels de la santé de première et deuxième ligne pourrait améliorer la santé et le bien-être des patients atteints de diabète de type 2 grâce à une approche holistique en accord avec les directives internationales, tout en permettant d'optimiser les coûts.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Le projet Care4Diabetes est actuellement mis en œuvre à l'échelle européenne dans 12 pays, parmi lesquels participent la Belgique (Wallonie), l'Espagne, la Bulgarie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, Malte, le Portugal, la Slovaquie et la Slovincie, grâce au cofinancement de la Commission européenne. En Belgique, le projet bénéficie du cofinancement de Sciensano et reçoit une subvention supplémentaire du ministère wallon de la Santé via l'AViQ (Agence wallonne pour une Vie de Qualité), ainsi qu'un soutien matériel de LifeScan. Du point de vue de l'organisation, l'AViQ s'est avéré être un partenaire clé dans la mise en œuvre des programmes pilotes en Wallonie, en nous orientant vers les structures de santé capables de prendre en charge ce projet, à savoir les réseaux locaux multidisciplinaires. Ce sont finalement les réseaux locaux multidisciplinaires UOAD (province de Namur) et Chronicare (province de Luxembourg) qui ont accepté de coordonner au niveau local la mise en œuvre de ce projet.

En termes d'expertise, le projet bénéficie du soutien d'un comité consultatif regroupant divers représentants du secteur, parmi lesquels figurent le RIZIV-INAMI, les Mutualités Libres, l'AViQ, la Diabetes Liga, l'Association du Diabète, RML UOAD, Chronicare,



Le programme Care4Diabetes s'appuie sur la collaboration des professionnels de santé des réseaux multidisciplinaires locaux UOAD et Chronicare

le SPF Santé publique, ainsi qu'un diabétologue du CHU UCL de Namur et deux médecins généralistes.

ACTIONS ENTREPRISES SUR LE TERRAIN

Le projet Care4Diabetes a débuté en février 2023 et s'étendra sur une période de 3 ans. Au cours de la première année, l'accent a été mis sur l'établissement de contacts avec les acteurs impliqués dans le domaine du diabète de type 2, dans le but de réaliser un diagnostic de la situation actuelle. Les réseaux locaux multidisciplinaires chargés de la prise en charge des patients atteints de diabète de type 2 en trajet de démarrage et trajet de soins se sont révélés être les plus enclins à mettre en œuvre le projet. Après une sélection basée sur leur volonté de participer et leurs capacités à le faire, le RML UOAD et Chronicare ont été retenus.

La première étape a consisté à former les équipes au programme Care4Diabetes basé sur la bonne pratique "Keer Diabetes2 Om" de Voeding Leeft. Chaque équipe s'est appropriée le programme afin de répondre du mieux qu'il soit au contexte local tout en gardant les principes fondamentaux du programme.

En janvier 2024, les premiers jours du programme ont débuté avec des retours positifs de la part des équipes de soins et des participants. Ce premier groupe pilote se conclura en décembre 2024. Un deuxième groupe débutera en octobre 2024 en parallèle, intégrant les retours des acteurs, des équipes et des participants du premier groupe afin d'améliorer continuellement le programme. A mon sens, cette volonté européenne de vouloir perfectionner le programme représente une véritable force car elle améliore l'adhésion des participants au programme et accroît son efficacité. Il n'y a pas vocation ici à faire un essai clinique à proprement parlé. Pour le moment, avec l'application des nouvelles conditions du trajet de démarrage, nous avons choisi de nous concentrer davantage sur les patients récemment diagnostiqués. Les patients en trajet de

soins ne sont pas exclus tant qu'ils répondent aux critères d'inclusion. Les principaux critères d'inclusion sont un diagnostic de diabète inférieur à 6 ans et l'utilisation de médicaments pour contrôler la glycémie sauf les inhibiteurs de SGLT2 et le GLP1. Ces critères seront réévalués au besoin. Les premiers résultats sont attendus pour fin juillet 2024.

PERSPECTIVES FUTURES

Une évaluation approfondie des enseignements tirés de cette expérience sera entreprise, permettant ainsi une compréhension approfondie des aspects fonctionnels et dysfonctionnels du programme en région wallonne. La transférabilité du programme offrira des connaissances sur les obstacles et les facteurs favorables à la mise en œuvre de programmes éducatifs multidimensionnels intensifs en groupe. Envisager ensuite une extension du programme à la région bruxelloise et flamande pourrait se révéler particulièrement intéressant. Il serait nécessaire d'explorer des pistes de financements possibles.

Charlotte Juton,
collaboratrice scientifique
CARE4DIABETES, Sciensano

Pour en savoir plus en tant que médecin ou professionnel de santé : <https://www.sciensano.be/en/projects/care4diabetes>

Pour en savoir plus sur les conditions d'accès au programme : <https://www.sciensano.be/fr/care4diabetes-pour-les-participants>

Les références bibliographiques sont disponibles sur demande au **02 374 31 95** ou par email à info@diabete.be